· 调查研究 ·

原发性肾病综合征患儿出院后延续性护理体验的质性研究

黄 静，马艺芳

Keywords primary nephrotic syndrome; children; continuity of care; qualitative research

摘要 **目的：**深入了解原发性肾病综合征患儿出院后进行延续性护理的体验，为提高延续性护理质量提供参考依据。**方法：**选取2023年1月—12月在广西壮族自治区崇左市人民医院儿科出院的8例进行延续性护理的原发性肾病综合征患儿及其家属进行半结构式访谈，使用Colaizzi 7步分析法深入分析访谈内容，提炼主题。**结果：**原发性肾病综合征患儿出院后延续性护理体验包括提升药物治疗信息的管理经验、生活调整与减轻心理负担、对延续性护理服务具有较高满意度、原发性肾病综合征患儿的延续性护理健康教育存在不足4个主题。**结论：**延续性护理不仅在提升患儿及其家属的药物治疗信息管理能力方面发挥了关键作用，还能有效减轻心理负担，提高整体服务满意度。然而，延续性护理在个性化健康教育资源提供方面存在不足，需要满足饮食指导和运动的个性化需求。

关键词 原发性肾病综合征；儿童；延续性护理；质性研究

doi：10.12104/j.issn.1674-4748.2025.14.021

原发性肾病综合征（primary nephrotic syndrome，PNS）是儿科常见的疾病，主要是肾小球基膜的通透性增加，导致大量血浆蛋白丢失，进而引起临床上的一系列症状和体征，如重度蛋白尿、低蛋白血症、水肿及高脂血症等[1-2]。目前，针对PNS的治疗主要依赖于激素和免疫抑制剂，但这些治疗方式存在明显的局限性。激素治疗不仅易使病人产生依赖，约60%的患儿还会经历蛋白尿的复发和不良反应。免疫抑制剂的使用则可能带来严重的副作用，影响肾功能，给患儿及其家庭造成重大负担[3]。延续性护理作为一种综合性的护理服务，已被证实能够有效提升慢性病病人的生命质量、自我管理能力及满意度，并有助于降低再次入院的风险[4]。特别是对于PNS患儿，通过为家庭成员提供健康教育、出院指导、随访干预等服务，不仅能够明显提高患儿的生活质量，还能改善其长期生存质量[5-7]。我院已建立了PNS延续性护理团队，在延续性护理过程中本团队不断地识别患儿及其家属面临的具体挑战和需求，并针对现有的延续性护理模式进行了一系列的优化和调整，取得了一定的成效。本研究为了更深入探索延续性护理应用效果，通过质性研究方法分析PNS患儿出院后的延续性护理体验，以期为未来改进延续性护理策略和提升病人满意度提供参考和指导。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采用目的性抽样法选取2023年1月—12月在广西壮族自治区崇左市人民医院儿科出院后进行延续性护理的原发性肾病综合征患儿及其家属为研究对象。纳入标准：1）患儿符合PNS的诊断标准[8]；2）患儿年龄≤14岁；3）患儿使用激素治疗或免疫治疗。排除标准：1）患儿与其家长有精神疾病史和认知障碍；2）患儿与其家长不具有良好沟通能力。本研究纳入的所有研究对象均知晓并愿意参与本次研究。本研究根据最大差异法选择不同人口资料具有代表性的研究对象，遵循信息饱和原则，当受访者所提供的信息不再有新的主题呈现时终止纳入。最终纳入了8例PNS患儿（C1～C8），12名PNS患儿的家属（P1～P12），共20人。受访者一般资料见表1。本研究经我院伦理委员会伦理审查批示，伦理号：KS202308（10）。

基金项目 崇左市科技计划项目，编号：崇科攻2023 ZC0301。

作者简介 黄静，副主任护师，本科，单位：532200，崇左市人民医院；马艺芳单位：崇左市人民医院。

引用信息 黄静，马艺芳.原发性肾病综合征患儿出院后延续性护理体验的质性研究[J].全科护理，2025，23（14）：2690-2694.

中国知网 https://www.cnki.net

表1 受访者一般资料

序号	性别	年龄(岁)	患儿病程/家属照顾时长(年)
C1	女	8	2.0
C2	女	10	3.0
C3	男	14	3.0
C4	女	14	4.0
C5	男	12	2.0
C6	女	13	1.0
C7	女	10	0.5
C8	男	13	3.0
P1	女	44	3.0
P2	女	32	2.0
P3	男	39	1.0
P4	女	38	0.5
P5	女	40	1.0
P6	女	42	3.0
P7	男	37	2.0
P8	女	39	3.0
P9	男	41	2.0
P10	女	35	1.0
P11	女	40	4.0
P12	女	36	3.0

1.2 访谈提纲

本研究PNS患儿延续性护理的方案主要包含了治疗后期管理(提供激素和免疫抑制剂治疗的副作用管理指导,包括识别早期症状和适当的应对措施)、药物依赖性和复发管理(建立复发预防计划,包括识别复发的早期迹象和立即采取的措施)、心理支持和应对策略(为患儿和家属提供心理健康支持,包括应对长期疾病的策略,如压力管理和情绪调节技巧培训)、生活方式和营养指导(提供个性化的饮食计划以及运动计划,帮助患儿减轻治疗副作用,如高血压和水肿)、教育和知识普及(提供易于理解的教育材料,包括药物使用指南)5个部分。本研究在PNS患儿延续性护理方案的基础上,根据张晓曼等[9]所调查的PNS患儿家长延续性护理需求调查结果,制定本研究提纲。见表2。

表2 访谈提纲

访谈对象	访谈问题
患儿	1)你能告诉我你是如何发现自己生病的吗?当时有哪些不舒服的症状呢?
	2)当你从医院回家后,有哪些事情变了吗?在治疗后,这些症状消失了吗?现在还有哪些地方不舒服吗?
	3)你不舒服的这些症状再出现过吗,你是怎么发现的?这时候你会怎么做?
	4)我们给了一些建议,比如怎么吃、怎么运动能帮助你感觉更好?你有没有试过这些建议?有没有觉得有用?
	5)除了吃和运动以外,出院后医护人员到家中给你提供帮助的过程中,你有哪些记忆最深刻?哪一部分你觉得对你最有帮助?
	6)在治疗期间,有没有时候让你觉得特别高兴或者特别难过?你是怎么让自己感觉好一点的?
	7)你觉得帮助你的这些叔叔阿姨有可以改进的地方吗?
家属	1)在您的孩子使用激素或免疫抑制剂治疗后,我们的副作用管理指导是否对您有所帮助?
	2)您如何评价我们为预防病情复发提供的指导和支持?是否觉得有效?
	3)我们的饮食和活动建议对您的孩子康复过程有实际帮助吗?您是否遇到了其他挑战?
	4)我们提供的疾病和治疗相关信息是否满足了您的需求?还有哪些额外的信息您认为是必要的?
	5)您觉得在出院后,我们医务人员提供的延续性护理有可以改进的地方吗?

1.3 资料收集方法

通过面对面的半结构访谈收集资料[10],由经过系统培训的研究者进行访谈。为了保护患儿,访谈地点均在患儿的卧室内,对家属的访谈在病人家属私密性较好的房间内,以确保一个熟悉且安全的环境。并且使用患儿可以听懂的语言,由浅入深地了解患儿以及家属在延续性护理过程中的真实感受。访谈时间节点在患儿出院后第3次延续性护理结束后。向患儿以及家属解释访谈的目的、内容,征得同意后并录音。按照访谈提纲进行半结构访谈,必要时追问。研究者在访谈过程中保持客观和中立的态度,同时记录参与者的语气、情绪、肢体语言和心情等非语言信息。如果患儿或其家属在访谈过程中感到不适,访谈将暂停,待受访者情绪平稳后再继续,若受访者明确表示不愿意继续参与访谈,立即终止访谈。

1.4 资料分析方法

访谈结束后24 h内,研究者将反复倾听录音并转录文本,形成访谈原始稿,之后由2名研究者进行文本校对,以确保准确性。本研究采用Colaizzi 7步分析法[11]来深入分析访谈内容,结合病人及家属的非语言沟通信息,提取关于PNS患儿及其家属对延续性护理体验的相关陈述。使用NVivo 11.0软件支持的编码分析,对观点进行分类并汇总共性特征和概念,从而揭示延续性护理体验与个人感受之间的内在联系,最终凝练成相关主题。

2 结果

2.1 主题1:提升药物治疗信息的管理经验

2.1.1 增强了患儿自我药物管理能力

大部分家属表示在激素或免疫抑制剂使用过程中缺乏详细的用药指导,导致对副作用的应对措施理解不足。一部分患儿仅知道自己做了什么治疗,但是不知道为何要做,一部分患儿则表示自己不知道做了哪种治疗,只知道具体治疗的形式。通过实施延续性护理后,可以知道为什么要做这个治疗,并且可以自觉地完成用药。一些家长表示可以更好地理解药物治疗方案,包括药物的正确用法和副作用的有效管理,提高了

中国知网 https://www.cnki.net

家长对治疗过程的信息认知与患儿的药物管理能力。C3:“我记得有一次药物副作用让我很难受,我不知道该怎么办。现在经过几次护士姐姐上门的教导,我学会了如何记录我的症状,而且知道了哪些副作用是正常的,哪些需要告诉她。”P2:“一开始我们对于激素和免疫抑制剂的副作用很担心,不知道如何应对。但是在延续性护理中,我们学到了很多关于如何管理这些副作用的知识,感觉更有信心了。”

2.1.2 破除信息沟通障碍

延续性护理期间分别定期和PNS患儿及家属沟通,使家长和患儿之间的信息沟通变得更加顺畅。医疗团队的积极介入改善了家庭内部信息不对称的问题,确保了药物调整和病情监测信息的准确传达。C6:“我觉得现在更容易和爸妈说我怎么样了,因为我们都知道病情和治疗方面的事。我们有时候会一起查看我的健康日志,然后讨论下一步该如何做。”

2.1.3 实时病情监测与调整

虽然一些家属最初在进行药物效果监测和记录病情变化时有困难,但延续性护理服务通过提供监测工具和知识支持,使家属能够更有效地进行实时病情监测和及时调整治疗方案。P2:“通过你们发给我的小程序,每天记录我儿子的症状,有问题时还不用去医院挂号,直接在上面问你们,真的很方便。”

2.1.4 强化家庭参与感

通过延续性护理增强了家庭参与,不仅提升了对原发性肾疾病的理解,还增加了家庭成员之间进行共同决策的机会。这种参与感和共同决策的过程能够增强患儿及家庭的自信心和自主性,同时提升了治疗方案的适应性和有效性。C4:“以前我觉得治疗就是医生和我妈说了算,但现在我和爸妈都能在讨论中表达我的想法。这让我觉得我也在帮助自己变得更好。”P1:“我觉得久病成医有一定道理,在你们上门不断讲解这个疾病时,我自己也查了很多资料,通过一起参与治疗计划的制订,我们感到自己更有能力支持我们的孩子。了解更多关于疾病和治疗的信息让我们能够更好地帮助孩子,也让孩子感到更加安心。”

2.2 主题2:生活调整与减轻心理负担

2.2.1 日常生活适应性指导

延续性护理团队为患儿及家庭提供具体的日常生活适应性指导,包括时间管理、家庭日常活动的调整等,帮助他们在维持治疗连贯性的同时,还能保持生活的正常运转,减轻由于治疗带来的日常生活干扰。C8:“护士姐姐帮助我学会了怎样安排我的作业和治疗时间,这样我就不会因为去医院复查错过太多课。”P11:“时间管理建议真的很有用,特别是在处理孩子的预约挂号和家庭其他事情冲撞的时候。”

2.2.2 有效的心理支持活动

延续性护理期间提供的心理健康支持,如咨询服务和心理教育,有效减轻了家庭面对疾病的长期压力和不确定性的心理负担。C5:“有时候我会觉得很害怕或者不确定,因为不知道我的病情会怎样。每次护士姐姐来都会对我进行各种鼓励,有时还会给我带玩具。”P2:“看着孩子因为疾病而感到焦虑和不安,对我们来说是很难的。通过延续性护理提供的心理支持,我们也慢慢学到了如何支持我们的孩子,也帮助我们自己处理这种情况。”

2.2.3 情绪波动与应对策略

延续性护理提供的情绪管理工具和策略帮助患儿和家庭更好地应对疾病复发或治疗过程中的情绪波动,提升了他们的应对能力和心理韧性。C4:“护士姐姐让我学到了其他一些应对技巧,比如深呼吸和想象,这些都让我在感到难过时能够自我安慰。”

2.3 主题3:对延续性护理服务具有较高满意度

2.3.1 小程序健康管理工具

延续性护理服务通过引入微信小程序健康云,使用手机微信记录病情变化、药物剂量和生活方式的调整,提高了病人和家庭的参与度和自我管理能力。这种技术的融合不仅提高了治疗的透明度和效率,也使病人和家属能够实时监控健康状态,及时调整治疗方案,提高对延续性护理服务的满意度。P9:“有时候直接在小程序记录和跟踪治疗过程,还能与医院的主治医生和护士的沟通更加高效,我们经常直接分享小程序中的数据给你们。”

2.3.2 微信社群支持

延续性护理服务中加入了微信社群,可以和其他生病的患儿以及家长形成线上互助小组,为患儿及其家庭提供了分享经验和情感支持的平台。这种社群支持不仅强化了心理健康和情绪管理,也提供了针对治疗和生活管理的实用建议,从而提高了整体满意度。C5:“我在微信里面认识了欢欢,我会分享我的故事和经历给她。她有时候也会和我分享。”P2:“我觉得你们创立的这个社群是我们的一个重要资源。它不仅为我们提供了情感上的支持,还给家长与孩子创造了一个病友交流平台,这一点我觉得做得很好。”

2.4 主题4:PNS患儿的延续性护理健康教育存在不足

2.4.1 专业知识与家庭实际操作的脱节

比如饮食建议过于笼统,在一些家长和患儿的报告中,延续性护理中提供的饮食建议通常缺乏具体性,未能考虑到患儿的个人口味、家庭饮食习惯或特殊营养需求。这种一刀切的建议很难能有效地融入患儿的日常生活中,导致家庭在尝试改善患儿饮食时感到困惑和挫败。P7:“你们说我们要吃得健康,但我不知道那对我意味着什么,这个概念太过笼统,每个人的口味

中国知网 https://www.cnki.net

和习惯都不同,我们需要的是能够针对我们孩子具体情况的建议,而不是通用的指导原则。”

2.4.2 活动与运动未考虑患儿实际能力和兴趣

家长指出,尽管被鼓励让患儿参与更多的运动活动,但延续性护理中的建议往往没有考虑到患儿的实际体能水平、健康状况或个人兴趣。缺少这种个性化的考量使得患儿难以找到真正适合自己的、能够持续参与的运动形式,进而影响了他们对运动的积极性和整体健康改善的效果。P7:“我们鼓励孩子多做运动,但是找到适合他当前健康状况的活动很难。我们担心过度运动可能会对他不好,但又不知道怎样的活动强度是安全的。”

2.4.3 教育资源的多样化和个性化不足

目前由于延续性护理教育的资源限制,大多数教育方式除了上门口头教育,还有线上公众号分享,但每个孩子的学习方式和接受能力都不同,多数家长表示可以提供视频、音频、互动应用程序等多种形式的教育方式,以满足不同患儿的需求。P9:“我们家的孩子你给他讲再多,一会儿就忘记了。但如果有视觉或者听觉的材料,比如视频或者有声书,他可能会更愿意学习关于疾病相关知识。”

3 讨论

3.1 延续性护理可以提升PNS患儿及其家属的自我管理能力

延续性护理作为一种整合性和多维护理模式[12]对于PNS患儿及其家属自我管理能力的提升至关重要。本研究发现,延续性护理可以有效提升患儿及家属在药物管理和情绪管理方面的自我管理能力。药物治疗在PNS管理中占据核心地位,因此患儿对药物的正确使用和管理能力尤为重要。研究发现,在延续性护理模式下,患儿可以得到详尽的药物使用指导和副作用管理知识,能够更有效地参与自己的治疗过程[13-15]。在本研究所采用延续性护理模式中,强调了药物教育的重要性。患儿在学习如何记录药物副作用,何时需要调整剂量或寻求医疗帮助中增强了自我管理能力,这不仅提高了患儿的治疗依从性,也减少了因药物使用不当导致的健康风险。PNS的长期管理和治疗可能导致患儿面临明显的情绪压力,延续性护理通过提供情绪支持和心理健康教育,帮助患儿更好地管理自身情绪[16]。在延续性护理中,通过学习应对策略,如情绪调节技巧、压力管理方法等,患儿能够更有效地处理与疾病相关的焦虑和不确定性,这种自我情绪管理能力的提升对于患儿的生活质量有直接的正面影响。对于家属而言,对药物治疗信息的准确理解和管理同样重要。延续性护理通过提供定期的教育会议和资料,使家属能够更好地理解药物的作用、管理副作用以及监测治疗进展[17]。家属自我管理能力的增强不仅使他们能够更有效地支持患儿的治疗,还有助于构建一个更加积极和支持性的家庭治疗环境。综上所述,延续性护理为PNS患儿提供了全面的支持,可以提高患儿及其家属的药物管理和情绪管理能力。这种自我管理能力的提升不仅对患儿的治疗效果有直接的正面影响,也为家庭带来了更多的希望和自信,从而提高了治疗的满意度和生活质量。

3.2 延续性护理消除PNS患儿与其家属之间的沟通障碍,增强共同参与感

本研究发现,延续性护理通过改善信息交流、提升家庭内部的协作与决策参与度,进而加强了患儿及其家属的共同参与感,有效地改善了医疗团队与患儿及其家属之间的信息交流。这种改善不仅涉及治疗计划的透明共享,也包括对患儿病情、治疗进展和可能的副作用等方面的信息交流。通过提供清晰、及时的信息,延续性护理帮助患儿及家属更好地理解治疗过程,降低了由于信息不对称引起的焦虑和不确定性[18-19]。在延续性护理模式下,患儿及家属不仅作为信息的接收者,也被鼓励作为治疗过程中的积极参与者,这种模式强调家庭内部的协作和共同决策,使得家庭成员能够在治疗和护理决策中拥有更多的发言权[20-21]。通过共同参与治疗计划的讨论和决策,家庭成员之间的沟通和理解得到加强,共同参与感得以增强。延续性护理中的教育和支持不仅限于疾病和治疗知识的传授,也包括培养患儿及家属的决策能力。通过增强他们对疾病管理和治疗选择的理解,延续性护理促使患儿及其家属能够更加自信地参与到治疗决策中,从而提高了整体治疗满意度和参与度。

3.3 健康管理工具辅助延续性护理可以提升病人满意度

延续性护理服务通过引入创新的健康管理工具和社群支持,明显提高了PNS患儿及其家庭的满意度。本研究结果显示,微信小程序健康云等工具的应用以及微信社群的建立,不仅增强了病人和家属的参与度和自我管理能力,还提升了信息透明度、沟通效率和心理支持的质量[22]。微信小程序健康云的使用使病人和家属能够通过手机微信记录病情变化、药物剂量和生活方式的调整,明显提高了治疗过程的透明度和自我管理效率。这种技术的融合不仅让病人和家属实时监测健康状态,及时调整治疗方案,直接在小程序中记录和跟踪治疗过程,使得与医疗团队的沟通更为高效,这种即时的数据分享和反馈机制是提升延续性护理服务满意度的关键因素[23]。在本研究中引入的微信社群为患儿及其家庭提供了一个分享经验和情感支持的平台,强化了病人和家属的心理健康和情绪管理。社群内的互助小组不仅提供了针对治疗和生活管理的实用建议,还增强了参与者之间的共情和支持,强调了社群作为情感支持和病友交流平台的重要性。这种线上社群的支持对于提升整体满意度具有显著影响,特别

中国知网 https://www.cnki.net

是在提供情感支持和增加治疗参与感方面[24-25]。其他研究显示通过技术和社群的力量可以有效提升病人治疗的参与度和满意度。未来的研究可以进一步探讨如何有效地集成和优化这些工具和资源,以进一步提高延续性护理服务的质量和效果。

3.4 开展个性化健康教育,优化延续性护理病人教育

本研究结果显示,开展个性化健康教育是优化延续性护理服务和提升病人教育效果的关键策略,这一观点也得到其他研究的证实。个性化健康教育需要考虑到病人的具体情况,包括病情严重程度、年龄、教育背景、文化习俗以及家庭环境等因素,旨在提供最适合病人的教育内容和方式。这种方法不仅能够增强病人对疾病知识的理解和接受度,还能够提升他们对治疗计划的依从性,因为教育内容更加贴合病人的实际需要和能力。应该采用多样化的教育方式以增强个性化健康教育的效果,除了传统的面对面教育,还可以利用数字工具如健康管理应用程序、在线视频、互动问答等方式,提供更加灵活和多样化的教育体验。这种多渠道的教育方法能够满足不同病人的学习偏好,提高教育内容的吸收和利用率。未来在延续性护理病人教育中,能够鼓励病人及其家属参与到健康教育的计划和实施过程中,进一步提升教育的个性化水平和满意度。通过收集病人的反馈和建议,医疗团队能够更好地理解病人的需求和期望,从而设计出更加符合病人需求的教育计划。

4 小结

本研究通过半结构式访谈,深入探讨延续性护理在PNS患儿及其家属中的应用效果,提炼出提升药物治疗信息的管理经验、生活调整与减轻心理负担、对延续性护理服务具有较高满意度、PNS患儿的延续性护理健康教育存在不足4个主题。延续性护理不仅加强了PNS患儿及其家属的自我管理能力,提高了对药物使用和情绪管理的认识,还通过优化信息交流和增强决策参与度,提升了治疗过程中的透明度和家庭内部协作。此外,引入微信小程序健康云和建立微信社群等健康管理工具,进一步提高了病人和家庭的参与度,未来的延续性护理实践应继续探索利用现代技术提高教育的个性化和参与度,以进一步提升病人满意度和治疗效果。

参考文献:

[1] LI F X,HOU Y L,ZHOU L S,*et al*.The status and model of children primary nephrotic syndrome in continuing nursing[J]. Annals of Palliative Medicine,2021,10(3):2398-2407.

[2] WANG Z,TANG H Y,LIN Q,*et al*.Incidence of thromboembolism in children with primary nephrotic syndrome:a systematic review and meta analysis[J].BMC Nephrology,2023,24(1):120.

[3] 路宽.儿童原发性肾病综合征临床特点及复发因素分析[D].石家庄:河北医科大学,2023.

[4] 胡树菁,王奕,高宝,等.远程干预在肺移植患者延续性护理中应用的范围综述[J].中华护理杂志,2023,58(14):1773-1780.

[5] 李凤霞.儿童原发性肾病综合征延续护理模式的构建[D].济南:山东大学,2018.

[6] 赵成广,傅桐,侯玲,等.血浆治疗儿童原发性肾病综合征重度水肿的临床疗效[J].中国医科大学学报,2021,50(9):827-832.

[7] 沈小钰,殷蕾,沙莎,等.儿童原发性肾病综合征106例复发时动态血压影响因素分析[J].中国实用儿科杂志,2023,38(11):863-868.

[8] CHARUEL E,BERNARD M,VAILLANT ROUSSEL H,*et al*. "I can't go far":perceptions and experiences of heart failure patients regarding physical activity:a qualitative study using semistructured face-to-face interviews[J].Health Education & Behavior,2022,49(1):78-86.

[9] 张晓曼,李振香,马昕璐,等.原发性肾病综合征患儿家长延续护理需求调查[J].中国实用护理杂志,2020,36(24):1880-1885.

[10] 徐婷婷,张伟英,付聪慧,等.ICU护士护理谵妄患儿体验的质性研究[J].中华护理杂志,2021,56(7):972-976.

[11] 夏青,杨俊雅,杨亮,等.延续护理服务对中青年维持性血液透析患者自我管理行为和生活质量的效果[J].河北医药,2023,45(9):1427-1430.

[12] SPITALETTA G,BIAGIOLI V,GRECO F,*et al*.Self-care in children and young people with complex chronic conditions:a qualitative study using Emotional Text Mining[J].Frontiers in Pediatrics,2023,11:1170268.

[13] 谭术鑫,汪裕伟.成人原发性肾病综合征免疫抑制治疗的研究进展[J].湘南学院学报(医学版),2024,26(2):71-75.

[14] 解艳欢.原发性肾病综合征免疫发病机制研究[J].医学信息,2023,36(20):189-192.

[15] GENNA C,THEKKAN K R,GEREMIA C,*et al*.Parents' process of recognition and response to clinical deterioration of their children with medical complexity at home:a grounded theory[J].Journal of Clinical Nursing,2023,32(15/16):4677-4693.

[16] PRITLOVE C,MARKOWITZ B,MUKERJI G,*et al*.Experiences and perspectives of the parents of emerging adults living with type 1 diabetes[J].BMJ Open Diabetes Research & Care,2020,8(1):e001125.

[17] 陈悦,李萍,毛艳,等.头颈肿瘤气管切开带管出院患者家庭参与式延续护理的实施[J].护理学杂志,2022,37(18):98-101.

[18] VANHOLDER R,DE WEGGHELEIRE A,IVANOV D D,*et al*. Continuing kidney care in conflicts[J].Nature Reviews Nephrology,2022,18(8):479-480.

[19] CAMERON J S.The continued care of children with renal disease into adult life[J].Pediatric Nephrology,2001,16(8):680-685.

[20] 吴国凤,李芯睿,钟美容,等.基于云平台的延续护理对乳腺癌患者阈下抑郁影响的研究[J].中华护理杂志,2024,59(2):142-148.

[21] CHEN J M,XU Q Q,PENG J,*et al*.Effects of WeChat platform-based continuing care on self-management and quality of life in patients with arthritis:a quasi-experimental study[J].Digital Health,2023,9:20552076231197104.

[22] 常林.奥马哈系统在原发性肾病综合征患儿延续护理中的应用及效果评价[D].太原:山西医科大学,2018.

[23] LI N,HAO J,FU T,*et al*.Evaluating the quality of life of 231 children with primary nephrotic syndrome and assessing parental awareness of the disease[J].Frontiers in Pediatrics,2021,9:745444.

[24] 涂娟,陈朝英,杨宏仙,等.10岁以上儿童原发性肾病综合征临床表现及预后[J].中华儿科杂志,2023,61(8):708-713.

[25] 李想.延续性护理对原发性肾病综合征患儿治疗依从性及其家属护理工作满意度的影响[J].慢性病学杂志,2019,20(10):1548-1549.

(收稿日期:2024-07-08;修回日期:2025-07-18)

(本文编辑 蒋尔丹)

中国知网 https://www.cnki.net